ΜΠΟΝΟΥΣ 1

Τράπεζα 200 Συμπερασμάτων Γνωμάτευσης

200 έτοιμα Συμπεράσματα / Εντυπώσεις για φυσιολογική εξέταση, τυχαίο εύρημα και επείγον εύρημα, ταξινομημένα ανά απεικονιστική μέθοδο και σύστημα. Κλείστε τη γνωμάτευσή σας με μία μόνο, σαφή πρόταση, ώστε όποιος τη διαβάζει να ξέρει τι πρέπει να κάνει.

Περιεχόμενα

Πώς γράφεται το συμπέρασμα γνωμάτευσης

Ακτινογραφία — 50 προτάσεις

Αξονική — 70 προτάσεις

Μαγνητική — 35 προτάσεις

Υπερηχογράφημα / Doppler — 45 προτάσεις

Επόμενο βήμα

ΓΙΑ ΑΡΧΗ

Πώς γράφεται το συμπέρασμα γνωμάτευσης

Βήμα ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ: απάντηση στο κλινικό ερώτημα, πρώτα το σημαντικότερο εύρημα και, εφόσον χρειάζεται, σύσταση και ενημέρωση.

> *Οι περισσότεροι κλινικοί ιατροί διαβάζουν πρώτα την ενότητα Συμπέρασμα. Όσο καλά κι αν είναι τα Ευρήματα, αν το Συμπέρασμα είναι ασαφές, η γνωμάτευση μένει ελλιπής.*

1. **Απαντήστε πρώτα στο κλινικό ερώτημα** — αν το ερώτημα ήταν «σκωληκοειδίτιδα;», η πρώτη πρόταση πρέπει να λέει αν υπάρχει ή όχι σκωληκοειδίτιδα.
2. **Ταξινόμηση κατά σειρά σημαντικότητας** — το επείγον εύρημα πάντα πρώτο· τα τυχαία ευρήματα στο τέλος.
3. **Μην επαναλαμβάνετε τα ευρήματα, ερμηνεύστε τα** — το Συμπέρασμα δεν είναι αντίγραφο των Ευρημάτων, αλλά το νόημά τους.
4. **Γράψτε συγκεκριμένη σύσταση** — αντί για «συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση», ποια εξέταση και γιατί.
5. **Σε επείγον εύρημα καταγράψτε την ενημέρωση** — σε ποιον, τι ώρα και με ποιον τρόπο έγινε η ενημέρωση.

Τύποι προτάσεων

ΕΤΙΚΕΤΑ	ΠΟΤΕ	ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	Χωρίς παθολογία ή χωρίς μεταβολή· περιορισμοί της αξιολόγησης.	43 προτάσεις
ΕΥΡΗΜΑ	Συνήθη ευρήματα σχετικά με το κλινικό ερώτημα.	82 προτάσεις
ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ	Τυχαίο εύρημα· με σύσταση για γενική συσχέτιση ή παρακολούθηση.	26 προτάσεις
ΕΠΕΙΓΟΝ	Εύρημα που πρέπει να αναφερθεί αμέσως· με καταγραφή της ενημέρωσης.	49 προτάσεις

Σχετικά με τα διαστήματα παρακολούθησης

Στις προτάσεις για τυχαία ευρήματα δεν δίνονται διαστήματα παρακολούθησης ή όρια μεγέθους. Η παρακολούθηση όζων, βλαβών επινεφριδίων, κύστεων και παρόμοιων ευρημάτων καθορίζεται με βάση το προφίλ κινδύνου του ασθενούς και τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες που έχει υιοθετήσει το ίδρυμά σας· μη γράφετε στη γνωμάτευση έναν αριθμό για τον οποίο δεν είστε βέβαιοι, ρωτήστε τον επιμελητή σας.

Αγκύλες

[δεξιά/αριστερά], **[.. mm]**, **[ώρα]** συμπληρώστε τα πεδία αυτά και διαγράψτε τις επιλογές που δεν ταιριάζουν. Στη γνωμάτευση δεν πρέπει να μείνει καμία αγκύλη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ακτινογραφία

50 συμπεράσματα γνωμάτευσης, ανά σύστημα.

Ακτινογραφία · Θώρακας

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
001	Στην ακτινογραφία θώρακος δεν διαπιστώνεται οξεία καρδιοπνευμονική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
002	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
003	Στην ακτινογραφία κλίνης δεν παρατηρείται νέα σκίαση, συλλογή ή πνευμοθώρακας.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
004	Σωλήνες και καθετήρες σε κατάλληλη θέση· δεν παρατηρούνται επιπλοκές σχετιζόμενες με την παρέμβαση.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
005	[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] πύκνωση· σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα μπορεί να είναι συμβατή με πνευμονία.	ΕΥΡΗΜΑ
006	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, [δεξιά κάτω ζώνη] πύκνωση: εμφανής υποχώρηση.	ΕΥΡΗΜΑ
007	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, [δεξιά κάτω ζώνη] πύκνωση: αύξηση· συνιστάται κλινική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
008	[Δεξιά/Αριστερά] [μικρή/μέτρια/μεγάλη] ποσότητα υπεζωκοτικής συλλογής.	ΕΥΡΗΜΑ
009	Αμφοτερόπλευρη μικρή υπεζωκοτική συλλογή και παθητική ατελεκτασία των βάσεων.	ΕΥΡΗΜΑ
010	[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] λοβός: ατελεκτασία· εφόσον χρειάζεται, συνιστάται αξονική τομογραφία για κεντρική αποφρακτική αιτία.	ΕΥΡΗΜΑ
011	Γραμμοειδής (δισκοειδής) ατελεκτασία στις βάσεις.	ΕΥΡΗΜΑ
012	Καρδιομεγαλία (σε οπισθοπρόσθια ακτινογραφία).	ΕΥΡΗΜΑ
013	Λόγω της προβολής ΑΡ, η αξιολόγηση του μεγέθους της καρδιάς είναι περιορισμένη.	ΕΥΡΗΜΑ
014	Ευρήματα υπέρ πνευμονικού οιδήματος· συνιστάται κλινική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
015	Ευρήματα πνευμονικής φλεβικής συμφόρησης.	ΕΥΡΗΜΑ
016	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, υποχώρηση των ευρημάτων πνευμονικού οιδήματος.	ΕΥΡΗΜΑ
017	[Δεξιά/Αριστερά] πνεύμονας [ζώνη]: [.. mm] χωροκατακτητική βλάβη· συνιστάται αξονική τομογραφία θώρακος με σκιαγραφικό.	ΕΥΡΗΜΑ
018	[Δεξιά/Αριστερά] [ζώνη]: κοιλοτική βλάβη· συνιστάται κλινική συσχέτιση και αξονική τομογραφία για λοιμώδεις διεργασίες και νεόπλασμα.	ΕΥΡΗΜΑ

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
019	Αμφοτερόπλευρες διάχυτες κεγχροειδείς οζώδεις σκιάσεις (κεγχροειδές πρότυπο)· συνιστάται κλινική και μικροβιολογική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
020	Ευρήματα υπερδιάτασης· μπορεί να είναι συμβατά με ΧΑΠ.	ΕΥΡΗΜΑ
021	[Δεξιά/Αριστερά] [..] η πλευρά: κάταγμα· δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας.	ΕΥΡΗΜΑ
022	Άκρο ενδοτραχειακού σωλήνα [.. cm] πάνω από την τρόπιδα, σε κατάλληλη θέση.	ΕΥΡΗΜΑ
023	Άκρο κεντρικού φλεβικού καθετήρα στην προβολή της άνω κοίλης φλέβας· δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας.	ΕΥΡΗΜΑ
024	[Δεξιά/Αριστερά] [ζώνη] : [.. mm] οζώδης σκίαση· για χαρακτηρισμό συνιστάται κλινική συσχέτιση και, εφόσον χρειάζεται, αξονική τομογραφία.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
025	Αθηρωματικές επασβεστωμένες αλλοιώσεις της αορτής.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
026	[Δεξιά/Αριστερά] πνευμοθώρακας. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
027	[Δεξιά/Αριστερά] εκτεταμένος πνευμοθώρακας και ακτινολογικά ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα], τηλεφωνικά.	ΕΠΕΙΓΟΝ
028	Άκρο ενδοτραχειακού σωλήνα [δεξιός κύριος βρόγχος] στην προβολή. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
029	Άκρο ρινογαστρικού σωλήνα [δεξιός κύριος βρόγχος] στην προβολή, όχι σε κατάλληλη θέση· πριν από τη χρήση η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
030	Εμφανής διεύρυνση του μεσοθωρακίου· σε περίπτωση τραύματος ή θωρακικού άλγους, συνιστάται επείγουσα αξονική αγγειογραφία για παθολογία της αορτής. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Ακτινογραφία · Κοιλία

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
031	Στην απλή ακτινογραφία κοιλίας δεν διαπιστώνονται ευρήματα υπέρ απόφραξης ή ελεύθερου αέρα.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
032	Η κατανομή των αερίων του εντέρου είναι φυσιολογική.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
033	Ευρήματα συμβατά με απόφραξη λεπτού εντέρου· συνιστάται αξονική τομογραφία κοιλίας με σκιαγραφικό.	ΕΥΡΗΜΑ
034	Εμφανές φορτίο κοπράνων στο κόλον.	ΕΥΡΗΜΑ
035	[Δεξιά/Αριστερά] [εντόπιση] στην προβολή: πυκνότητα πιθανώς συμβατή με ακτινοσκιερό λίθο· συνιστάται συσχέτιση με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό.	ΕΥΡΗΜΑ
036	Επασβεστωμένες πυκνότητες στην πύελο, πιθανώς συμβατές με φλεβόλιθους.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
037	Ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα (πνευμοπεριτόναιο). Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
038	Ευρήματα υπέρ συστροφής σιγμοειδούς. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Ακτινογραφία · Μυοσκελετικό

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
039	[Δεξιά/Αριστερά] [περιοχή]: δεν διαπιστώνεται οξεία οστική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
040	Δεν παρατηρείται κάταγμα ή εξάρθρημα· τα μεσάρθρια διαστήματα διατηρούνται.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
041	Δεν παρατηρείται γραμμή κατάγματος· εάν η κλινική υποψία επιμένει, το αφανές κάταγμα δεν μπορεί να αποκλειστεί με την ακτινογραφία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
042	[Δεξιά/Αριστερά] κάταγμα περιφερικής κερκίδας ([ενδαρθρικό/εξωαρθρικό], [ραχιαία] γωνίωση).	ΕΥΡΗΜΑ
043	[Δεξιά/Αριστερά] σκαφοειδές [μέσης μοίρας] κάταγμα.	ΕΥΡΗΜΑ
044	[Δεξιά/Αριστερά] [πρόσθιο] εξάρθρημα γληνοβραχιονίου· συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά την ανάταξη.	ΕΥΡΗΜΑ
045	[Δεξιά/Αριστερά] [έξω σφυρό] κάταγμα· ποδοκνημική λαβίδα (mortise) [διατηρημένη/διευρυμένη].	ΕΥΡΗΜΑ
046	Μετά την ανάταξη, η ευθυγράμμιση των τμημάτων του κατάγματος είναι [αποδεκτή/διαταραγμένη].	ΕΥΡΗΜΑ
047	[Δεξιά/Αριστερά] γόνατο: εκφυλιστικές αλλοιώσεις (οστεοαρθρίτιδα)· χωρίς οξεία οστική παθολογία.	ΕΥΡΗΜΑ
048	Σημείο οπίσθιου λιπώδους επιθέματος· συνιστάται ορθοπαιδική αξιολόγηση για αφανές κάταγμα.	ΕΥΡΗΜΑ
049	[Οστό]: [.. mm] λυτική βλάβη· για χαρακτηρισμό συνιστάται κλινική συσχέτιση και περαιτέρω διερεύνηση.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
050	[Δεξιά/Αριστερά] κάταγμα αυχένα μηριαίου ([με παρεκτόπιση/χωρίς παρεκτόπιση]). Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αξονική τομογραφία

70 συμπεράσματα γνωμάτευσης, ανά σύστημα.

Αξονική · Νευροακτινολογία

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
051	Στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό δεν διαπιστώνεται οξεία ενδοκρανιακή παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
052	Δεν παρατηρείται ενδοκρανιακή αιμορραγία, φαινόμενο μάζας ή παρεκτόπιση της μέσης γραμμής.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
053	Η πρώιμη ισχαιμία μπορεί να μη φαίνεται στην αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό· εάν η κλινική υποψία επιμένει, μπορεί να εξεταστεί μαγνητική τομογραφία με DWI.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
054	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση δεν παρατηρείται νέα αιμορραγία ή αύξηση του φαινομένου μάζας.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
055	Εγκεφαλική ατροφία ανάλογη της ηλικίας· δεν διαπιστώνεται οξεία παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
056	Περικοιλιακές υποπυκνότητες πιθανώς συμβατές με χρόνια νόσο μικρών αγγείων.	ΕΥΡΗΜΑ
057	[Δεξιά/Αριστερά] [εντόπιση]: περιοχή εγκεφαλομαλακίας συμβατή με παλαιό έμφρακτο.	ΕΥΡΗΜΑ
058	[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] χωροκατακτητική βλάβη και αγγειογενές οίδημα· συνιστάται μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό.	ΕΥΡΗΜΑ
059	[Εντόπιση] ευρήματα συμβατά με παραρρινοκολπίτιδα.	ΕΥΡΗΜΑ
060	[Δεξιά/Αριστερά] [οστό] γραμμοειδές κάταγμα· δεν παρατηρείται συνοδός ενδοκρανιακή αιμορραγία.	ΕΥΡΗΜΑ
061	[Εντόπιση]: εξωαξονική βλάβη με επασβεστώσεις· μπορεί να είναι συμβατή με μηνιγγίωμα, συνιστάται συσχέτιση με μαγνητική τομογραφία.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
062	[Εντόπιση]: βλάβη πυκνότητας ΕΝΥ, πιθανώς συμβατή με αραχνοειδή κύστη.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
063	[Δεξιά/Αριστερά] οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα· [.. mm] παρεκτόπιση της μέσης γραμμής. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
064	[Δεξιά/Αριστερά] οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα· υπάρχει φαινόμενο μάζας. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
065	Υπαραχνοειδής αιμορραγία· συνιστάται αξονική αγγειογραφία για ανεύρυσμα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
066	[Δεξιά/Αριστερά] [εντόπιση] οξύ ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα, διάνοιξη στις κοιλίες [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
067	[Δεξιά/Αριστερά] Ευρήματα πρώιμης οξείας ισχαιμίας στην αγγειακή περιοχή της MCA· χωρίς αιμορραγία. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
068	[Δεξιά/Αριστερά] Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας στη MCA· μπορεί να είναι υπέρ οξέος θρόμβου, συνιστάται αξονική αγγειογραφία. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
069	Ευρήματα υπέρ οξέος αποφρακτικού υδροκεφάλου. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
070	[Υποδρεπανοειδής/Διασκηνιδιακός/Αμυγδαλικός] ευρήματα εγκολεασμού. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
071	[Δεξιά/Αριστερά] [οστό] κάταγμα με εμβύθιση και υποκείμενη [εξωαξονική αιμορραγία]. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
072	Στην αξονική αγγειογραφία [δεξιά/αριστερά] [MCA M1] τμήμα: απόφραξη. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Αξονική · Θώρακας

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
073	Στην αξονική τομογραφία θώρακος δεν διαπιστώνεται σημαντική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
074	Στην αξονική πνευμονική αγγειογραφία δεν διαπιστώνεται πνευμονική θρομβοεμβολή.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
075	Λόγω ανεπαρκούς σκιαγράφησης των πνευμονικών αρτηριών, η αξιολόγηση σε υποτμηματικό επίπεδο είναι περιορισμένη.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
076	[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] πύκνωση· μπορεί να είναι συμβατή με λοιμώδη διεργασία.	ΕΥΡΗΜΑ
077	Αμφοτερόπλευρες θολώσεις τύπου θαμβής υάλου· στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται λοιμώδεις και φλεγμονώδεις διεργασίες, συνιστάται κλινική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
078	[Κεντρολοβιακό] εμφύσημα.	ΕΥΡΗΜΑ
079	Μεσοθωρακικοί λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους· πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο.	ΕΥΡΗΜΑ
080	[Δεξιά/Αριστερά] πνεύμονας: [.. mm] χωροκατακτητική βλάβη και [πυλαία/μεσοθωρακική] λεμφαδενοπάθεια· συνιστάται κλινική αξιολόγηση για ιστολογική διάγνωση.	ΕΥΡΗΜΑ
081	[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός]: [.. mm] [συμπαγής] όζος· η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστεί μαζί με την κλινική ομάδα, με βάση το προφίλ κινδύνου και τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
082	Επασβεστώσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
083	Θυρεοειδής [δεξιά/αριστερά] λοβός: υπόπυκνος όζος· συνιστάται αξιολόγηση με υπερηχογράφημα.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
084	[Αμφοτερόπλευρη] οξεία πνευμονική θρομβοεμβολή· ευρήματα υπερφόρτωσης δεξιάς κοιλίας [υπάρχει/δεν υπάρχει]. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
085	[Με συμμετοχή/Χωρίς συμμετοχή της ανιούσας αορτής] διαχωρισμός αορτής. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
086	[Δεξιά/Αριστερά] πνευμοθώρακας. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
087	Πνευμομεσοθωράκιο· εάν υπάρχει κλινική υποψία διάτρησης οισοφάγου, συνιστάται περαιτέρω αξιολόγηση. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
088	[Μέτρια/Μεγάλη] ποσότητα περικαρδιακής συλλογής· συνιστάται επείγουσα κλινική και υπερηχοκαρδιογραφική αξιολόγηση για επιπωματισμό. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Αξονική · Κοιλία και πύελος

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
089	Στην αξονική τομογραφία κοιλίας-πυέλου δεν διαπιστώνεται οξεία παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
090	Η σκωληκοειδής απόφυση έχει φυσιολογική εικόνα· δεν διαπιστώνονται ευρήματα υπέρ οξείας σκωληκοειδίτιδας.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
091	Στην αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό δεν διαπιστώνεται λιθίαση ουροποιητικού ή υδρονέφρωση.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
092	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, [βλάβη]: χωρίς εμφανή μεταβολή.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
093	[Σιγμοειδές] κόλον: οξεία μη επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα.	ΕΥΡΗΜΑ
094	[Δεξιά/Αριστερά] [περιφερικό] ουρητήρας: [.. mm] λίθος και [ήπια] υδρουρητηρονέφρωση.	ΕΥΡΗΜΑ
095	Οξεία [διάμεση οιδηματώδης] παγκρεατίτιδα.	ΕΥΡΗΜΑ
096	Ευρήματα υπέρ οξείας χολοκυστίτιδας· συνιστάται συσχέτιση με υπερηχογράφημα.	ΕΥΡΗΜΑ
097	Χολολιθίαση· δεν παρατηρούνται ευρήματα υπέρ οξείας χολοκυστίτιδας.	ΕΥΡΗΜΑ
098	Πολλαπλές ηπατικές βλάβες πιθανώς συμβατές με μεταστάσεις· συνιστάται κλινική και, εφόσον χρειάζεται, ιστοπαθολογική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
099	Ηπατική στεάτωση.	ΕΥΡΗΜΑ
100	[Μικρή/Μέτρια] ποσότητα ασκιτικού υγρού.	ΕΥΡΗΜΑ
101	[Εντόπιση] κόλον: πάχυνση τοιχώματος· στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται φλεγμονώδη, λοιμώδη και νεοπλασματικά αίτια, συνιστάται ενδοσκοπική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
102	Ήπαρ, τμήμα [..]: βλάβη συμβατή με απλή κύστη.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
103	[Δεξιά/Αριστερά] νεφρός: βλάβη συμβατή με απλή κύστη.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
104	[Δεξιά/Αριστερά] όζος επινεφριδίου· ο χαρακτηρισμός και η παρακολούθηση πρέπει να καθοριστούν μαζί με την κλινική ομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
105	[Δεξιά/Αριστερά] νεφρός: [.. mm] βλάβη μη χαρακτηρίσιμη· για περαιτέρω αξιολόγηση συνιστάται [δυναμική αξονική/μαγνητική] .	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
106	Στο ήπαρ, μη χαρακτηρίσιμη στην παρούσα εξέταση, [.. mm] υπόπυκνη βλάβη· εφόσον χρειάζεται, συνιστάται αξιολόγηση με δυναμική μαγνητική τομογραφία.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
107	Ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
108	Ευρήματα οξείας σκωληκοειδίτιδας και [περισκωληκοειδικό απόστημα/διάτρηση] (ευρήματα). Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
109	Πνευμοπεριτόναιο· [πιθανή εντόπιση] : υπέρ διάτρησης. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
110	Ζώνη μετάβασης [περιοχή]: ευρήματα υπέρ μηχανικής απόφραξης λεπτού εντέρου και ισχαιμίας. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
111	Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και περιαορτικό αιμάτωμα υπέρ ρήξης. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
112	Κάκωση σπλήνα, αιμοπεριτόναιο και ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
113	Πνευμάτωση του εντερικού τοιχώματος και αέρας στην πυλαία φλέβα· συνιστάται επείγουσα κλινική αξιολόγηση για μεσεντέρια ισχαιμία. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
114	[Δεξιά/Αριστερά] αποφρακτικός λίθος ουρητήρα και [περινεφρική συλλογή/εμφυσηματώδεις αλλοιώσεις]· εάν υπάρχει κλινική υποψία λοιμώδους απόφραξης, συνιστάται επείγουσα αξιολόγηση. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Αξονική · Σπονδυλική στήλη και μυοσκελετικό

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
115	Στην αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας δεν διαπιστώνεται οξεία τραυματική οστική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
116	Η συνδεσμική κάκωση δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως με την αξονική τομογραφία· εάν υπάρχουν νευρολογικά ευρήματα, συνιστάται μαγνητική τομογραφία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
117	[L1] σπόνδυλος: συμπιεστικό κάταγμα οξείας εμφάνισης· δεν παρατηρείται στένωση του σπονδυλικού σωλήνα.	ΕΥΡΗΜΑ
118	Εκφυλιστικές αλλοιώσεις των οσφυϊκών σπονδύλων.	ΕΥΡΗΜΑ
119	[Σπόνδυλος] σπονδυλικό σώμα: σκληρυντική εστία· μπορεί να είναι συμβατή με οστικό νησίδιο, συνιστάται κλινική συσχέτιση.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
120	[Επίπεδο] επίπεδο: κάταγμα/εξάρθρημα ασταθούς εμφάνισης και στένωση του σπονδυλικού σωλήνα. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Μαγνητική τομογραφία

35 συμπεράσματα γνωμάτευσης, ανά σύστημα.

Μαγνητική · Νευροακτινολογία

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
121	Στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν διαπιστώνεται σημαντική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
122	Στην DWI δεν διαπιστώνεται περιορισμός της διάχυσης υπέρ οξέος εμφράκτου.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
123	Δεν παρατηρείται παθολογική ενίσχυση μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
124	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση δεν παρατηρείται νέα ή ενισχυόμενη βλάβη.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
125	Αλλοιώσεις της λευκής ουσίας πιθανώς συμβατές με χρόνια νόσο μικρών αγγείων· χωρίς οξύ έμφρακτο.	ΕΥΡΗΜΑ
126	Βλάβες της λευκής ουσίας πιθανώς συμβατές με απομυελινωτική νόσο· πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την κλινική εικόνα και τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια.	ΕΥΡΗΜΑ
127	[Περιοχή]: εξωαξονική μάζα συμβατή με μηνιγγίωμα.	ΕΥΡΗΜΑ
128	Υπόφυση [μικρο/μακρο]αδένωμα (συμβατή βλάβη)· συνιστάται ενδοκρινολογική συσχέτιση.	ΕΥΡΗΜΑ
129	[Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] ενδοαξονική μάζα με δακτυλιοειδή ενίσχυση· στη διαφορική διάγνωση πρωτίστως όγκος γλοίας υψηλού βαθμού κακοήθειας και μετάσταση.	ΕΥΡΗΜΑ
130	Κυστική βλάβη πιθανώς συμβατή με κύστη επίφυσης.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
131	[Εντόπιση]: εικόνα συμβατή με αναπτυξιακή φλεβική ανωμαλία.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
132	[Δεξιά/Αριστερά] [αρτηρία] αγγειακή περιοχή: οξύ έμφρακτο. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
133	Ευρήματα συμβατά με εγκεφαλικό απόστημα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
134	[Κόλπος] θρόμβωση. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
135	Οξεία αιμορραγία εντός βλάβης της υπόφυσης και πίεση του οπτικού χιάσματος· συνιστάται επείγουσα κλινική αξιολόγηση για αποπληξία. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαγνητική · Σπονδυλική στήλη

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
136	Στη μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας δεν διαπιστώνεται σημαντική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
137	Πέραν της εκφύλισης δίσκων, δεν διαπιστώνονται σημαντικά ευρήματα πίεσης.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
138	L [4-5] [δεξιά παράμεση] εξώθηση δίσκου· [L5] νευρική ρίζα: πίεση.	ΕΥΡΗΜΑ
139	C [5-6] σύμπλεγμα δίσκου-οστεοφύτου και [δεξιά] στένωση τρήματος· χωρίς μεταβολή σήματος στον νωτιαίο μυελό.	ΕΥΡΗΜΑ
140	[L1] σπόνδυλος: [οξύ/υποξύ] συμπιεστικό κάταγμα· δεν παρατηρούνται ευρήματα υπέρ παθολογικού κατάγματος.	ΕΥΡΗΜΑ
141	[Σπόνδυλος] σπονδυλικό σώμα: βλάβη συμβατή με τυπικό αιμαγγείωμα.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
142	[Επίπεδο] επίπεδο: βλάβη πιθανώς συμβατή με επισκληρίδια επέκταση όγκου και πίεση του νωτιαίου μυελού. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
143	[Επίπεδο] επίπεδο: μεγάλη εξώθηση δίσκου και σημαντική πίεση των ριζών της ιππουρίδας· συνιστάται επείγουσα αξιολόγηση σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαγνητική · Μυοσκελετικό

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
144	[Δεξιά/Αριστερά] γόνατο: στη μαγνητική τομογραφία δεν διαπιστώνεται σημαντική παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
145	[Ολικού πάχους] ρήξη ΠΧΣ και [έξω διαμέρισμα] θλάσεις οστού.	ΕΥΡΗΜΑ
146	[Έσω] μηνίσκος [οπίσθιο κέρας] [λοξή] ρήξη.	ΕΥΡΗΜΑ
147	Στον τένοντα του υπερακανθίου: [ολικού πάχους] ρήξη· απόσυρση [.. mm].	ΕΥΡΗΜΑ
148	[Δεξιά/Αριστερά] άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής· δεν παρατηρείται κατάρρευση αρθρικής επιφάνειας.	ΕΥΡΗΜΑ
149	Ιγνυακή κύστη (Baker)· χωρίς ευρήματα ρήξης.	ΕΥΡΗΜΑ
150	[Περιοχή]: προσβολή μυελού των οστών και [υποπεριοστική/μαλακών μορίων] συλλογή· συνιστάται επείγουσα κλινική αξιολόγηση για οστεομυελίτιδα και απόστημα. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαγνητική · Κοιλία και πύελος

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
151	Στη δυναμική μαγνητική τομογραφία ήπατος δεν διαπιστώνεται εστιακή βλάβη.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
152	Ήπαρ, τμήμα [..]: βλάβη συμβατή με τυπικό αιμαγγείωμα.	ΕΥΡΗΜΑ

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
153	Λίθος στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου (χοληδοχολιθίαση) και διάταση των χοληφόρων.	ΕΥΡΗΜΑ
154	[Δεξιά/Αριστερά] ωοθήκη: βλάβη συμβατή με απλή κύστη· η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστεί από την κλινική ομάδα.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
155	Στο πάγκρεας [.. mm] κυστική βλάβη· ο χαρακτηρισμός και η παρακολούθηση πρέπει να καθοριστούν μαζί με την κλινική ομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Υπερηχογράφημα / Doppler

45 συμπεράσματα γνωμάτευσης, ανά σύστημα.

Υπερηχογράφημα / Doppler · Κοιλία

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
156	Στο υπερηχογράφημα όλης της κοιλίας δεν διαπιστώνεται παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
157	Χοληδόχος κύστη χωρίς ιδιαιτερότητες· δεν παρατηρούνται λίθοι ή ευρήματα οξείας χολοκυστίτιδας.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
158	Τα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφόρα δεν είναι διατεταμένα.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
159	Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό στην κοιλία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
160	Λόγω των αερίων του εντέρου, η αξιολόγηση του παγκρέατος είναι περιορισμένη.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
161	Χολολιθίαση· δεν παρατηρούνται ευρήματα υπέρ οξείας χολοκυστίτιδας.	ΕΥΡΗΜΑ
162	Λάσπη χοληδόχου κύστης (sludge).	ΕΥΡΗΜΑ
163	[Ήπια/Μέτρια/Σημαντική] εικόνα συμβατή με ηπατική στεάτωση.	ΕΥΡΗΜΑ
164	Αδρή ηχοδομή και οζώδες περίγραμμα, πιθανώς συμβατά με χρόνια ηπατοπάθεια.	ΕΥΡΗΜΑ
165	Σπληνομεγαλία.	ΕΥΡΗΜΑ
166	Διάταση του χοληδόχου πόρου· εάν δεν προσδιορίζεται αιτία, συνιστάται MRCP.	ΕΥΡΗΜΑ
167	[Μικρή/Μέτρια/Μεγάλη] ποσότητα ασκιτικού υγρού.	ΕΥΡΗΜΑ
168	Ήπαρ, τμήμα [..]: υπερηχογενής βλάβη πιθανώς συμβατή με αιμαγγείωμα· ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
169	Στη χοληδόχο κύστη [.. mm] πολύποδας· η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
170	Ευρήματα συμβατά με οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
171	Ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
172	[Ειλεοκολικός] εγκολεασμός: συμβατά ευρήματα. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
173	Ήπαρ, τμήμα [..]: βλάβη πιθανώς συμβατή με απόστημα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπερηχογράφημα / Doppler · Ουρογεννητικό και πύελος

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
174	Στο υπερηχογράφημα ουροποιητικού δεν διαπιστώνεται παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
175	Στο υπερηχογράφημα Doppler οσχέου η ορχική ροή είναι συμμετρική αμφοτερόπλευρα· δεν διαπιστώνεται παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
176	[Δεξιά/Αριστερά] [ήπια/μέτρια] υδρονέφρωση· [πιθανή αιτία].	ΕΥΡΗΜΑ
177	[Δεξιά/Αριστερά] νεφρός: [.. mm] λίθος· χωρίς υδρονέφρωση.	ΕΥΡΗΜΑ
178	[Δεξιά/Αριστερά] ευρήματα συμβατά με επιδιδυμοορχίτιδα· η ορχική ροή διατηρείται.	ΕΥΡΗΜΑ
179	[Δεξιά/Αριστερά] νεφρός: απλή φλοιώδης κύστη.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
180	Προστάτης [διογκωμένος]· συνιστάται κλινική συσχέτιση.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
181	[Δεξιά/Αριστερά] ευρήματα συμβατά με συστροφή όρχεως. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
182	Δεν παρατηρείται ενδομήτρια κύηση· ευρήματα υπέρ εξωμήτριας κύησης με μάζα εξαρτημάτων και ελεύθερο υγρό. [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπερηχογράφημα / Doppler · Αγγειακό

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
183	[Δεξιά/Αριστερά] κάτω άκρο: δεν διαπιστώνεται θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
184	Δεν διαπιστώνονται ευρήματα υπέρ αιμοδυναμικά σημαντικής στένωσης στις καρωτίδες αμφοτερόπλευρα.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
185	[Δεξιά/Αριστερά] [έσω καρωτίδα] αρτηρία: αθηροσκληρωτική πλάκα· βαθμός στένωσης σύμφωνα με τα κριτήρια του ιδρύματος: [βαθμός].	ΕΥΡΗΜΑ
186	[Δεξιά/Αριστερά] ευρήματα συμβατά με θρόμβωση επιπολής φλέβας· το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα είναι βατό.	ΕΥΡΗΜΑ
187	Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, στον θρόμβο: [επανασηραγγοποίηση/καμία μεταβολή].	ΕΥΡΗΜΑ
188	Στην υπονεφρική κοιλιακή αορτή: [.. mm] διάταση· η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστεί μαζί με την κλινική ομάδα.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ
189	[Δεξιά/Αριστερά] [μηροϊγνυακό] τμήμα: οξεία εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
190	Σε συμπτωματικό ασθενή [.. mm] ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής· η ρήξη δεν μπορεί να αποκλειστεί με υπερηχογράφημα, συνιστάται επείγουσα αξονική αγγειογραφία. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπερηχογράφημα / Doppler · Τράχηλος και επιφανειακοί ιστοί

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
191	Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς δεν διαπιστώνεται παθολογία.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
192	Δεν διαπιστώνονται λεμφαδένες παθολογικής εμφάνισης στον τράχηλο.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
193	Θυρεοειδής [δεξιός λοβός]: [.. mm] όζος· σύμφωνα με την ταξινόμηση κινδύνου του ιδρύματός σας: [κατηγορία].	ΕΥΡΗΜΑ
194	Ετερογενής ηχοδομή πιθανώς συμβατή με διάχυτη νόσο του θυρεοειδικού παρεγχύματος· συνιστάται συσχέτιση με τις δοκιμασίες θυρεοειδικής λειτουργίας.	ΕΥΡΗΜΑ
195	[Περιοχή]: συλλογή συμβατή με απόστημα μαλακών μορίων και ευρήματα περιβάλλουσας κυτταρίτιδας.	ΕΥΡΗΜΑ
196	[Δεξιά/Αριστερά] μαστός: βλάβη συμβατή με απλή κύστη.	ΤΥΧΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ

Υπερηχογράφημα / Doppler · POCUS και eFAST

ΑΡ.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΕΝΤΥΠΩΣΗ	ΤΥΠΟΣ
197	Στο eFAST δεν διαπιστώνονται ευρήματα υπέρ ελεύθερου υγρού, περικαρδιακής συλλογής ή πνευμοθώρακα. Το αρνητικό eFAST δεν αποκλείει κάκωση οργάνου.	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
198	Αμφοτερόπλευρες διάχυτες γραμμές Β· συμβατό με διάμεσο σύνδρομο.	ΕΥΡΗΜΑ
199	FAST θετικό: [Στον θύλακο του Morison] ελεύθερο υγρό. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ
200	[Δεξιά/Αριστερά] δεν παρατηρείται ολίσθηση του πνεύμονα και αναγνωρίζεται σημείο πνεύμονα (lung point)· υπέρ πνευμοθώρακα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [Ώρα].	ΕΠΕΙΓΟΝ

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα το Μπόνους 2 · 50 Λάθη Γνωμάτευσης που Διορθώνει Συχνότερα ο Επιμελητής. Μάθατε να επιλέγετε το σωστό συμπέρασμα γνωμάτευσης· τώρα αναγνωρίστε τα λάθη που κάνουν τη γνωμάτευση να επιστρέφεται και μην τα επαναλάβετε.

Για να δείτε τις προτάσεις μέσα σε πλήρη γνωμάτευση, μπορείτε να επιστρέψετε στο **Κύριο υλικό · 120 Έτοιμα Πρότυπα Γνωμάτευσης**.